

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CEFALEAS

Para Profesionales de Salud

ÍNDICE

1. Interpretación por Medicina Occidental
 2. Interpretación por Medicina Tradicional China
 3. Puntos clave de diagnóstico diferencial
 4. Banderas rojas y derivación urgente
 5. Recomendaciones de tratamiento integrado
-

1. INTERPRETACIÓN POR MEDICINA OCCIDENTAL

A. MIGRAÑA SIN AURA

Criterios diagnósticos (IHS): - Pregunta 20: Al menos 5 episodios - Pregunta 22: Duración 4-72 horas - Pregunta 26: Dolor unilateral - Pregunta 27: Dolor pulsátil - Pregunta 28: Intensidad moderada-severa (6-10) - Pregunta 31: Empeora con actividad física - Pregunta 34: Náuseas/vómitos presentes - Pregunta 33: Fotofobia o fonofobia

Factores sugestivos adicionales: - Pregunta 18: Antecedentes familiares positivos - Pregunta 30: Desencadenantes: estrés, alimentos, ciclo menstrual - Pregunta 68: Relación con menstruación (migraña menstrual)

B. MIGRAÑA CON AURA

Todo lo anterior MÁS: - Pregunta 33: Aura visual, sensitiva o del lenguaje - Aura completamente reversible - Duración del aura: 5-60 minutos - Cefalea sigue al aura (usualmente dentro de 60 min)

C. CEFALEA TENSIONAL

Criterios diagnósticos: - Pregunta 20: Al menos 10 episodios - Pregunta 22: Duración 30 min - 7 días - Pregunta 26: Bilateral - Pregunta 27: Opresiva/presión (no pulsátil) - Pregunta 28: Intensidad leve-moderada (3-6) - Pregunta 31: NO empeora con actividad física rutinaria - Pregunta 34: NO náuseas/vómitos (puede haber anorexia leve) - Pregunta 33: Fotofobia O fonofobia (no ambas) - Pregunta 46: Tensión muscular cervical/hombros

Clasificación: - Episódica infrecuente: <1 día/mes - Episódica frecuente: 1-14 días/mes - Crónica: 15 días/mes por >3 meses

D. CEFALEA EN RACIMOS

Criterios diagnósticos: - Pregunta 20: Al menos 5 ataques - Pregunta 22: Duración 15-180 minutos sin tratar - Pregunta 24: Unilateral, orbital/supraorbital/temporal - Pregunta 28: Intensidad severa-muy severa (8-10) - Pregunta 4: Más frecuente en hombres - Pregunta 29: Extremadamente incapacitante

Síntomas autonómicos ipsilaterales (preguntas 35-37): - Lagrimeo - Congestión nasal/rinorrea - Ptosis/edema palpebral - Miosis - Inquietud/agitación

Patrón temporal: - Pregunta 23: Mismo horario (frecuentemente nocturno) - Episodios en “racimos” (semanas-meses) con remisiones

E. CEFALEA POR USO EXCESIVO DE MEDICAMENTOS

Criterios: - Pregunta 20: 15 días/mes - Pregunta 21: >3 meses - Pregunta 73-74: Uso regular de analgésicos - Analgésicos simples: 15 días/mes - Triptanes/opioides: 10 días/mes - Pregunta 22: Cefalea presente al despertar

F. BANDERAS ROJAS (Pregunta 77)

DERIVACIÓN URGENTE si presenta:

1. **Cefalea súbita tipo “trueno”**
 - Considerar: hemorragia subaracnoidea
 - Acción: Neuroimagen urgente
 2. **Cefalea progresiva con cambios neurológicos**
 - Considerar: tumor, hematoma subdural
 - Acción: Neuroimagen urgente
 3. **Cefalea + fiebre + rigidez de nuca**
 - Considerar: meningitis, encefalitis
 - Acción: Evaluación urgente, punción lumbar
 4. **Cefalea con déficit neurológico focal**
 - Considerar: ACV, lesión ocupante de espacio
 - Acción: Neuroimagen urgente
 5. **Inicio después de los 50 años**
 - Considerar: arteritis temporal, neoplasia
 - Acción: VSG, PCR, evaluación oftalmológica
 6. **Post-traumática**
 - Considerar: hematoma, contusión
 - Acción: Neuroimagen según severidad
 7. **Cambios de personalidad/cognitivos**
 - Considerar: lesión frontal, hidrocefalia
 - Acción: Evaluación neurológica urgente
-

2. INTERPRETACIÓN POR MEDICINA TRADICIONAL CHINA

A. DIAGNÓSTICO POR PATRONES (ZHENG)

1. CEFALEA POR ASCENSO DE YANG DE HÍGADO **Manifestaciones clave:** - Pregunta 24: Localización temporal, vértex - Pregunta 27: Dolor pulsátil, tipo ascendente - Pregunta 42: Irritabilidad, frustración, ira - Pregunta 47: Sensación de calor en cabeza - Pregunta 49: Tinnitus/acúfenos - Pregunta 48: Mareos, vértigo - Pregunta 56: Lengua roja en bordes, capa amarilla - Pregunta 30: Desencadenado por estrés, ira

Mecanismo MTC: - Estancamiento de Qi de Hígado se transforma en Fuego - Yang de Hígado asciende perturbando el Orificio Claro - Puede combinarse con deficiencia de Yin de Riñón/Hígado

Puntos de acupuntura sugeridos: - GB20 (Fengchi) - dispersa Viento, baja Yang - LV3 (Taichong) - calma Hígado, desciende Yang - LV2 (Xingjian) - drena Fuego de Hígado - GB43 (Xiaxi) - drena Fuego de Vesícula Biliar - GV20 (Baihui) - calma Shen, desciende Yang - KI3 (Taixi) - nutre Yin de Riñón

Fitoterapia sugerida: - Tian Ma Gou Teng Yin (modificado) - Long Dan Xie Gan Tang (si hay Fuego)

2. CEFALEA POR ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO Manifestaciones clave: - Pregunta 27: Dolor opresivo, distensivo - Pregunta 24: Sienes, ambos lados - Pregunta 42: Depresión, frustración, suspiros frecuentes - Pregunta 41: Distensión abdominal - Pregunta 30: Empeora con estrés emocional - Pregunta 32: Mejora con relajación, masajes - Pregunta 56: Lengua con capa delgada - Pregunta 40: Heces irregulares

Mecanismo MTC: - Estancamiento de Qi de Hígado afecta circulación en canales - Qi estancado obstruye los meridianos de la cabeza - Puede combinarse con estancamiento de Sangre

Puntos de acupuntura sugeridos: - LV3 (Taichong) - mueve Qi de Hígado - LV14 (Qimen) - desbloquea Hígado - GB34 (Yanglingquan) - mueve Qi en Shaoyang - PC6 (Neiguan) - regula Qi, calma Shen - LI4 (Hegu) - mueve Qi, alivia dolor

Fitoterapia sugerida: - Xiao Yao San (dispersa Hígado, fortalece Bazo) - Chai Hu Shu Gan San (si predomina estancamiento)

3. CEFALEA POR DEFICIENCIA DE QI Y SANGRE Manifestaciones clave: - Pregunta 27: Dolor sordo, sensación de vacío - Pregunta 28: Intensidad leve-moderada - Pregunta 31: Empeora con esfuerzo, mejora con reposo - Pregunta 51: Fatiga, cansancio fácil - Pregunta 48: Mareos leves - Pregunta 44: Sueño no reparador - Pregunta 56: Lengua pálida - Pregunta 47: Sensación de frío, extremidades frías - Pregunta 30: Desencadenado por ayuno, falta de sueño

Mecanismo MTC: - Bazo/Estómago débil no producen suficiente Qi y Sangre - Meridianos de la cabeza mal nutridos - “El vacío genera dolor”

Puntos de acupuntura sugeridos: - ST36 (Zusanli) - tonifica Qi y Sangre - SP6 (Sanyinjiao) - nutre Sangre - CV6 (Qihai) - tonifica Qi - BL20 (Pishu) - fortalece Bazo - BL23 (Shenshu) - tonifica Riñón - GV20 (Baihui) - eleva Qi claro

Fitoterapia sugerida: - Ba Zhen Tang (Ocho Tesoros) - Gui Pi Tang (si hay componente de Corazón-Bazo)

4. CEFALEA POR DEFICIENCIA DE RIÑÓN Manifestaciones clave: - Pregunta 24: Occipital, zona posterior - Pregunta 27: Dolor profundo, vacío - Pregunta 22: Crónica, persistente - Pregunta 51: Fatiga crónica, agotamiento - Pregunta 49: Tinnitus crónico - Pregunta 47: Frío en zona lumbar, rodillas - Pregunta 44: Insomnio, despertar temprano - Pregunta 56: Lengua roja sin capa (Yin) o pálida (Yang) - Pregunta 4: Más frecuente después de 40 años

Diferenciación:

Deficiencia de Yin de Riñón: - Calor en 5 centros (manos, pies, pecho) - Sudor nocturno - Lengua roja, sin capa - Boca seca nocturna

Deficiencia de Yang de Riñón: - Frío generalizado - Extremidades frías - Lengua pálida, hinchada - Micción frecuente, clara

Puntos de acupuntura sugeridos: - BL23 (Shenshu) - tonifica Riñón - KI3 (Taixi) - nutre Yin de Riñón - GV4 (Mingmen) - tonifica Yang de Riñón - BL60 (Kunlun) - canal Tai Yang, cefalea occipital - GB39 (Xuanzhong) - nutre Médula

Fitoterapia sugerida: - Liu Wei Di Huang Wan (deficiencia Yin) - Jin Gui Shen Qi Wan (deficiencia Yang)

5. CEFALEA POR FLEMA-HUMEDAD Manifestaciones clave: - Pregunta 27: Pesadez, presión, sensación de venda - Pregunta 24: Frente, zona frontal - Pregunta 39: Náuseas, sensación de plenitud estomacal - Pregunta 41: Distensión abdominal - Pregunta 38: Apetito disminuido o irregular - Pregunta 48: Mareos, vértigo tipo rotatorio - Pregunta 56: Lengua con capa gruesa, blanca o amarilla - Pregunta 30: Empeora con humedad climática - Pregunta 65: Dieta irregular, alta en grasas

Mecanismo MTC: - Deficiencia de Bazo genera Humedad - Humedad se condensa en Flema - Flema obstruye el Yang Claro que debe ascender

Puntos de acupuntura sugeridos: - ST40 (Fenglong) - resuelve Flema - SP9 (Yinlingquan) - drena Humedad - ST8 (Touwei) - cefalea frontal por Flema - ST36 (Zusanli) - fortalece Bazo - CV12 (Zhongwan) - armoniza Estómago - PC6 (Neiguan) - calma náuseas

Fitoterapia sugerida: - Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang - Er Chen Tang (si predomina Flema)

6. CEFALEA POR VIENTO EXTERNO Manifestaciones clave: - Pregunta 21: Inicio reciente, agudo - Pregunta 24: Occipital, nuca, generalizada - Pregunta 27: Dolor variable, migratorio - Pregunta 30: Desencadenado por cambios climáticos, viento, frío - Pregunta 36: Congestión nasal - Pregunta 46: Rigidez nuchal - Pregunta 47: Aversión al frío o calor (según tipo)

Diferenciación:

Viento-Frío: - Aversión al frío - Sin sudoración - Secreciones nasales claras - Lengua con capa blanca

Viento-Calor: - Fiebre - Sudoración - Garganta dolorida - Secreciones amarillas - Lengua roja con capa amarilla

Puntos de acupuntura sugeridos: - GB20 (Fengchi) - expulsa Viento - GV16 (Fengfu) - expulsa Viento - BL12 (Fengmen) - expulsa Viento - LI4 (Hegu) - libera Exterior - LU7 (Lieque) - dispersa Viento-Frío

Fitoterapia sugerida: - Chuan Xiong Cha Tiao San (Viento-Frío) - Sang Ju Yin (Viento-Calor)

7. CEFALEA POR ESTASIS DE SANGRE Manifestaciones clave: - Pregunta 27: Punzante, fijo, lancinante - Pregunta 24: Localización fija, no cambia - Pregunta 25: Dolor NO se mueve - Pregunta 22: Crónica, persistente, nocturna - Pregunta 14: Antecedente de traumatismo craneal - Pregunta 56: Lengua púrpura, con puntos púrpura - Pregunta 32: Difícil de aliviar - Pregunta 28: Intensidad severa

Mecanismo MTC: - Trauma, estancamiento prolongado de Qi, o Frío causan estasis - “Si no fluye, hay dolor; si no hay dolor, fluye” - Sangre estancada obstruye los meridianos

Puntos de acupuntura sugeridos: - BL17 (Geshu) - punto Hui de Sangre - SP10 (Xuehai) - mueve Sangre - LV3 (Taichong) - mueve Qi y Sangre - LI4 (Hegu) - moviliza - SP6 (Sanyinjiao) - mueve Sangre - Puntos Ashi locales

Fitoterapia sugerida: - Tong Qiao Huo Xue Tang - Xue Fu Zhu Yu Tang

B. DIAGNÓSTICO POR CANALES (MERIDIANOS)

Canal Tai Yang (Vejiga)

- **Localización:** Occipital, nuca, zona posterior
- **Preguntas:** 24, 46
- **Puntos clave:** BL10, BL60, GB20, SI3

Canal Shao Yang (Vesícula Biliar)

- **Localización:** Temporal, lateral cabeza
- **Preguntas:** 24
- **Puntos clave:** GB20, GB8, GB14, GB43, TE5

Canal Yang Ming (Estómago)

- **Localización:** Frente, región frontal
- **Preguntas:** 24, 39
- **Puntos clave:** ST8, ST36, ST40, LI4

Canal Jue Yin (Hígado)

- **Localización:** Vértex, temporal
- **Preguntas:** 24, 42
- **Puntos clave:** LV3, GV20, GB20

3. PUNTOS CLAVE DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TABLA COMPARATIVA RÁPIDA

Tipo de Cefalea	Localización	Calidad	Duración	Síntomas asociados
Migraña	Unilateral	Pulsátil	4-72h	Náuseas, foto/fonofobia
Tensional	Bilateral	Opresiva	30min-7d	Tensión muscular
Racimos	Orbital unilateral	Muy severa	15-180min	Síntomas autonómicos
Yang Hígado↑	Temporal, vértex	Pulsátil	Variable	Irritabilidad, tinnitus
Qi-Sangre def	Difusa	Sorda, vacía	Crónica	Fatiga, palidez
Flema-Humedad	Frontal	Pesadez	Variable	Náuseas, mareos

4. EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS

Exámenes de Laboratorio Básicos:

- Hemograma completo (descartar anemia en def. Qi-Sangre)
- VSG, PCR (si >50 años o sospecha arteritis)
- Función tiroidea (TSH, T4)
- Glucemia
- Perfil lipídico

Neuroimagen (Indicaciones):

- Cefalea de inicio reciente >50 años
- Cambio en patrón de cefalea crónica
- Déficit neurológico focal
- Cefalea súbita severa
- Cefalea progresiva
- Alteraciones en examen neurológico

Evaluación Oftalmológica:

- Sospecha de glaucoma
 - Alteraciones visuales persistentes
 - 50 años con cefalea temporal (descartar arteritis)
-

5. RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO

A. ENFOQUE COMBINADO OCCIDENTAL-MTC

FASE AGUDA (Crisis de dolor): Medicina Occidental: - AINEs: Ibuprofeno 400-600mg, Naproxeno 500-1000mg - Triptanes: Sumatriptán 50-100mg (migraña) - Antieméticos: Metoclopramida si náuseas

MTC: - Acupuntura de alivio inmediato: - LI4 + LV3 (Si Guan - Cuatro Puertas) - GB20, GB21 bilateral - Puntos Ashi locales - GV20 (Baihui) - Yintang (extra)

TRATAMIENTO PREVENTIVO: Medicina Occidental (si 4 crisis/mes): - Beta-bloqueantes: Propranolol 40-240mg/día - Antidepresivos: Amitriptilina 10-75mg/noche - Anticonvulsivantes: Topiramato 50-200mg/día - Toxina botulínica (migraña crónica)

MTC: - Acupuntura preventiva: 1-2 sesiones/semana x 8-12 semanas - Fórmulas herbales según patrón (ver arriba) - Tratamiento constitucional de fondo

B. MODIFICACIONES DE ESTILO DE VIDA (Integradas)

Basadas en respuestas del cuestionario:

1. **Higiene del sueño** (Preguntas 44-45)
 - 7-8 horas regulares
 - Horarios consistentes
 - Evitar pantallas antes de dormir
2. **Hidratación** (Pregunta 58)
 - Mínimo 2 litros/día
 - Según MTC: agua tibia preferible
3. **Alimentación** (Preguntas 65-66)
 - **Occidental:** Evitar desencadenantes (chocolate, quesos, alcohol)
 - **MTC según patrón:**
 - Yang Hígado↑: Evitar picante, alcohol, café
 - Def. Qi-Sangre: Aumentar carne roja, vegetales verdes
 - Flema-Humedad: Evitar lácteos, fritos, dulces
4. **Ejercicio** (Preguntas 62-63)
 - Actividad aeróbica regular: 30min, 3-5x/semana
 - Evitar ejercicio intenso que desencadene migraña
 - MTC recomienda: Taiji, Qigong, yoga suave
5. **Manejo del estrés** (Pregunta 42)
 - Técnicas de relajación: respiración, meditación
 - Biofeedback
 - Terapia cognitivo-conductual
 - MTC: Regulación emocional, acupuntura
6. **Ergonomía** (Pregunta 64)

- Postura correcta frente a pantallas
- Pausas cada 20-30 minutos
- Iluminación adecuada

C. PROTOCOLO SUGERIDO INTEGRADO

Semanas 1-4: - Evaluación y diagnóstico completo - Diario de cefalea - Inicio de acupuntura (2x/semana)
- Ajustes dietéticos según patrón MTC - Medicación aguda según necesidad

Semanas 5-8: - Evaluación de respuesta - Ajuste de fórmulas herbales - Acupuntura (1-2x/semana) - Considerar preventivo occidental si no mejora - Refuerzo de modificaciones de estilo de vida

Semanas 9-12: - Consolidación de resultados - Reducción gradual de frecuencia de acupuntura - Mantenimiento de cambios de estilo de vida - Plan de seguimiento a largo plazo

6. CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Derivar a Neurología si:

- Banderas rojas presentes
- Cefalea refractaria a tratamiento (>3 meses sin mejora)
- Necesidad de neuroimagen
- Considerar preventivos complejos o toxina botulínica
- Sospecha de cefalea secundaria

Derivar a Urgencias si:

- Cefalea súbita “trueno”
- Déficit neurológico agudo
- Alteración de conciencia
- Cefalea + fiebre + rigidez nuchal
- Trauma craneal reciente con cefalea progresiva
- Convulsiones

Considerar interconsulta Psicología/Psiquiatría si:

- Comorbilidad psiquiátrica significativa
 - Depresión o ansiedad severa
 - Necesidad de terapia cognitivo-conductual
 - Abuso de medicamentos
-

7. DIARIO DE CEFALEA RECOMENDADO

Solicitar al paciente registrar durante al menos 4 semanas: - Fecha y hora de inicio - Duración - Intensidad (1-10) - Localización - Síntomas asociados - Medicamentos usados y efectividad - Posibles desencadenantes - Actividades del día - Fase del ciclo menstrual (mujeres)

8. RECURSOS ADICIONALES

Clasificación Internacional de Cefaleas (IHS):

<https://ichd-3.org/>

Medicina Tradicional China:

- Maciocia, G. “The Practice of Chinese Medicine”
- Deadman, P. “A Manual of Acupuncture”

Apps útiles para pacientes:

- Migraine Buddy
 - Headache Log
 - N1-Headache
-

NOTAS FINALES

- Este cuestionario y guía son herramientas de apoyo diagnóstico
 - El juicio clínico del profesional es insustituible
 - La integración de ambas medicinas puede ofrecer mejores resultados
 - Personalizar siempre el tratamiento según el paciente individual
 - Mantener comunicación abierta entre diferentes profesionales tratantes
-

Elaborado por: Sistema de Salud Integrativa **Versión:** 1.0 - 2026 **Revisión recomendada:** Anual o según nuevas guías clínicas

ANEXO: PUNTOS DE ACUPUNTURA MÁS UTILIZADOS EN CEFALEA

Puntos Generales (usar en casi todos los casos):

- **LI4 (Hegu):** Mueve Qi, alivia dolor, punto maestro facial
- **LV3 (Taichong):** Calma Hígado, mueve Qi, baja Yang
- **GB20 (Fengchi):** Expulsa Viento, alivia cefalea, punto local
- **GV20 (Baihui):** Eleva Yang Claro, calma Shen
- **Yintang (Extra):** Calma Shen, alivia cefalea frontal

Puntos Específicos por Localización:

- **Frontal:** ST8, Yintang, BL2
- **Temporal:** GB8, GB14, TE23, Taiyang (extra)
- **Vértex:** GV20, LV3, GB20
- **Occipital:** BL10, GB20, GV16, BL60

Puntos Específicos por Patrón:

- **Yang Hígado↑:** LV2, LV3, GB43, KI3
- **Estancamiento Qi:** LV3, LV14, PC6, GB34

- **Deficiencia Qi-Sangre:** ST36, SP6, BL20, CV6
- **Deficiencia Riñón:** BL23, KI3, GV4, KI6
- **Flema-Humedad:** ST40, SP9, CV12, ST36
- **Estasis Sangre:** BL17, SP10, SP6, LV3

Esta guía debe complementarse con el criterio clínico profesional y adaptarse a cada caso particular.